

Asignatura

Itinerario Personal para la Empleabilidad I

UNIDAD 3

Medidas de prevención y protección en la empresa



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Asignatura

Itinerario Personal para la Empleabilidad I

UNIDAD 3

Parte 2

Medidas de prevención y protección en la empresa

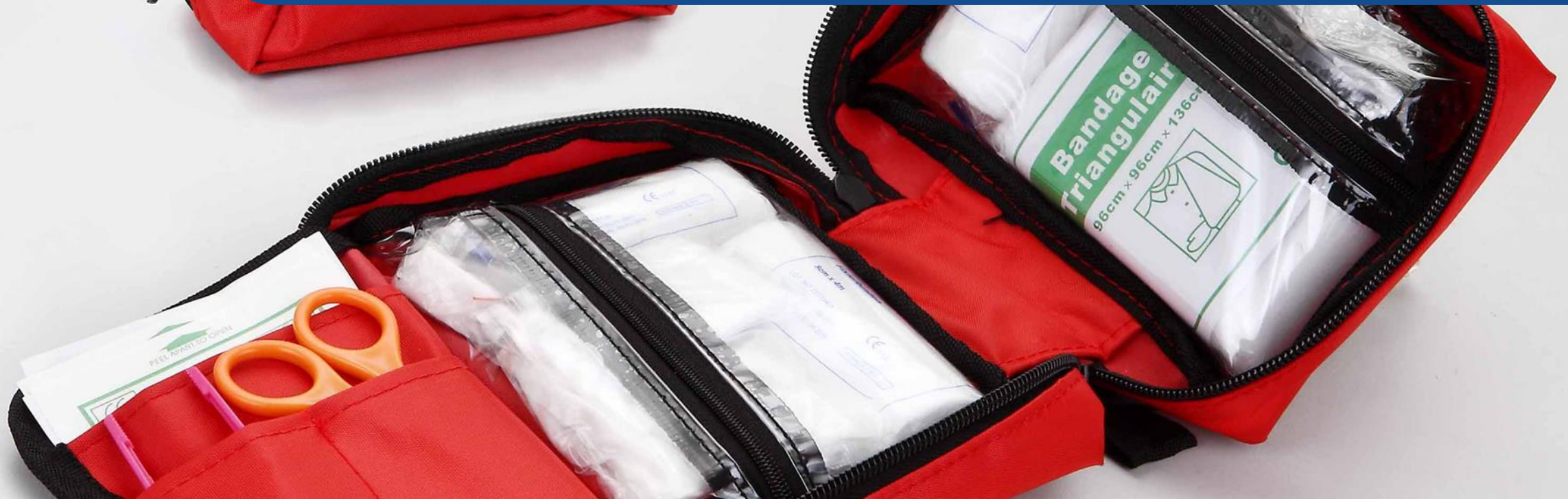


UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



* Técnicas básicas de primeros auxilios

Distintas instituciones y organizaciones de ámbito nacional, europeo e internacional, conviene que todos los ciudadanos sean capaces de actuar ante dichas situaciones, gracias a la adquisición de unas nociones básicas y primarias de primeros auxilios, que serán válidas para la vida real, ya sea laboral o no





Primeros auxilios

Pasos y técnicas que se realizan en un primero momento, de manera inmediata y no profesional, a una persona tras sufrir un accidente o una enfermedad repentina.

Objetivo:

- Preservar la vida
- Paliar el dolor
- Evitar lesiones secundarias (infecciones, enfermedades)



¿CÓMO ACTUAR ANTE UN ACCIDENTE?



1. Conducta PAS



Proteger el lugar del accidente.
Enciende las luces de emergencia, coloca los triángulos de peligro y averigua qué ha sucedido.



Alertar a los servicios de emergencia.
Indica el lugar del accidente, describe la situación, di cuántos heridos hay y su estado aparente. Identifícate y no cuelgues hasta que te lo indiquen.



Socorrer a las víctimas.
Evita movimientos del accidentado, haz una valoración inicial del mismo y en caso de hemorragia visible, aplica presión directamente sobre la herida.

2. Sistema "ABC" de la valoración inicial



A Airway
Se procede a la apertura de la vía aérea a través de la maniobra frente-mentón y descartar cuerpos extraños extraíbles.



B Breathing
Ver, oír y sentir la respiración en no más de 10 segundos.



C Circulation
Comprobar la circulación a través de la toma del pulso o la frecuencia cardíaca.



LUGAR DEL ACCIDENTE



¿Cómo se procede si el accidentado no responde?

3. RCP básica

30 compresiones
Colocando los brazos rectos, en la posición vertical del tórax, dejamos caer el peso de nuestro cuerpo deprimiendo el pecho del accidentado.



2 respiraciones

Abrir la vía aérea y proceder a la respiración "boca a boca", puede ser boca a boca o boca a nariz, si la boca está gravemente lesionada o no se puede abrir.



Si el accidentado responde se procede a ponerle en posición de seguridad (PLS), con el objetivo de que no se atragante con los fluidos que necesite arrojar por la boca.



En cambio, si el accidentado no responde, se ha de continuar haciendo la RCP hasta que haya señales de movimiento o llegue el personal médico de emergencia.



Conducta PAS

Proteger, Alertar y Socorrer
(Conciencia y respiración).



Sistema ABC

Airway, Breathing y Circulation
(Vía aérea, ventilación y circulación)



RCP básica

- **30** compresiones + **2** respiraciones.
- Si recupera - **PLS**
- Seguir maniobras hasta llegada de la ayuda, hasta que la persona se recupere o hasta el agotamiento.
- Si **DESA**, aplicarlo en el menor tiempo posible.

Resumen protocolo asistencial



VALORACIÓN PRIMARIA

PROTEGER

Comprobar la consciencia

↓ NO

¿RESPONDE?



Valorar su estado y pedir ayuda si es necesario

Pedir ayuda y abrir la vía aérea

↓ NO

¿RESPIRA?



Control de hemorragias:
Colocar en posición de
Recuperación (P.L.S)

↓ NO

Llamar al 112
Iniciar la reanimación

ALERTAR SOCORRER

RCP:

- Adultos: 30:2
- Niños: 15:2

OVACE



Maniobra de Heimlich:

- Si atragantamiento, anime a la víctima a toser.
- Si la tos resulta ineficaz, de hasta **5 golpes en la espalda** entre los omoplatos.
- Si los golpes en la espalda no son efectivos, de hasta **5 compresiones abdominales**.
- Si la obstrucción no se ha aliviado continúe alternando 5 golpes en la espalda con 5 compresiones abdominales hasta que se resuelva la obstrucción o bien la víctima quede inconsciente.
- Si la víctima queda **inconsciente**, avise al SEM e inicie la **RCP**

*** **Lactantes -> compresiones torácicas.**

Posición lateral de seguridad (PLS)

Características:

- Posición básica de espera.
- Para pacientes inconscientes.
- En presencia de vómitos o náuseas.

Como ejecutarla:

- Colocar a la persona decúbito supino (boca arriba).
- Flexionar brazo del lado interno formando un ángulo de 90° con su cuerpo.
- Con la pierna del lado interno recta, flexionamos la pierna del lado externo.
- Giramos el cuerpo hasta que quede de lado.
- Coloque el dorso de la mano del lado externo bajo la mejilla.





Clasificación de los heridos (triaje)

Cuando hay emergencia con múltiples heridos es necesario contar con un sistema de clasificación de víctimas (triaje) para determinar cuáles de ellos necesita prioridad de asistencia.

Fases de actuación en situaciones de emergencia con múltiples víctimas

Valorar la situación para la movilización de recursos

Priorizar las actuaciones

Atender primero a las víctimas inconscientes

Triaaje: valorar a las víctimas y clasificarlas

Estabilización de las víctimas y traslado



START (Simple triage and Rapid treatment)





Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones

Heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas,

Heridas

Definición

Lesión sangrante que aparecen en la piel produciendo su rotura. Se produce en los tejidos externos. Las complicaciones de las heridas son por riesgo de infección, shock hipovolémico o secuelas.

Para valorar la gravedad de la herida tendremos en cuenta:

- Profundidad
- Extensión
- Localización cráneo, cara, tórax o abdomen
- Sangrado o hemorragia
- Órganos afectados
- Combinación de los factores anteriores

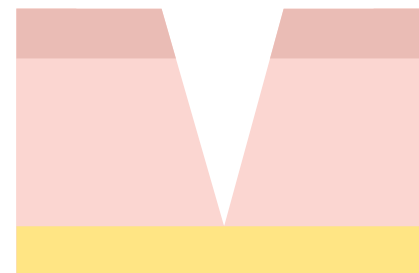
Dos clases de heridas:

- **Leves:** poca extensión y profundidad, no afecta a estructuras ni órganos, no infectada, no contiene cuerpos extraños.
- **Graves:** extensión importante. Profundidad importante, infectada,, hemorragia severa.

Una de la clasificación mas conocida para reconocer las heridas es según su forma y aspecto, pueden ser: incisas, contusas, punzantes, laceradas, abrasiones o desgarros.



Herida incisa



Herida punzante



Raspadura



Herida contusa





Protocolo de actuación en el tratamiento de heridas

1. Limpieza de manos y uso de guantes, y si fuese necesario mascarilla.
2. Evaluar la gravedad, aspecto de la herida y posibles complicaciones.
3. Aplicar siguiente procedimiento:

Heridas leves:

- Limpieza de herida con agua y jabón, desde el centro hacia los bordes de la herida.
- Aplicación de solución antiséptica, la más recomendada es clorhexidina.
- Cubrir con gasa estéril o apósito.
- Reforzar con esparadrapo o venda para evitar desplazamiento.

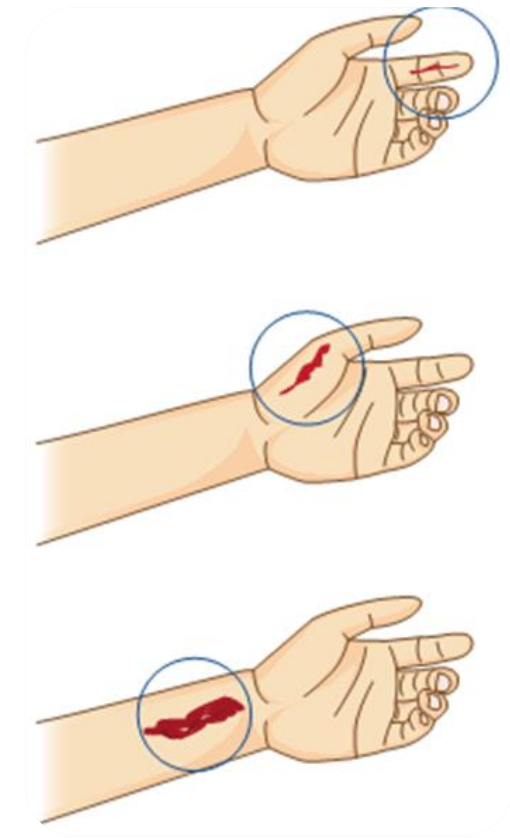
Recuerda no usar alcohol ni agua oxigenada.

Hemorragias

Las **hemorragias** son la rotura de uno o varios vasos sanguíneos que causan la salida de sangre dentro y/o fuera del organismo.

Las hemorragias se pueden diferenciar:

Según el tipo de vaso sanguíneo	Según la localización de la sangre
Capilar: procedente de los capilares, la sangre sale sin fuerza y continua. Se cierra sola. Aparecen hematomas.	Externa: sangre que sale fuera del organismo.
Venosa: Sangre de color rojo oscuro. Sale sin fuerza y continuo.	Interna: la sangre sale dentro del organismo acumulándose debajo de la piel o entre cualquier cavidad.
Arterial: Sangre roja y brillante. Sale de forma abundante e intermitentemente. Es difícil de controlar.	Exteriorizadas: son hemorragias internas donde la sangre sale al exterior por un orificio natural (oído, boca, ano, etc.).



Protocolo de actuación hemorragia interna

Procedimiento de actuación hemorragia interna:

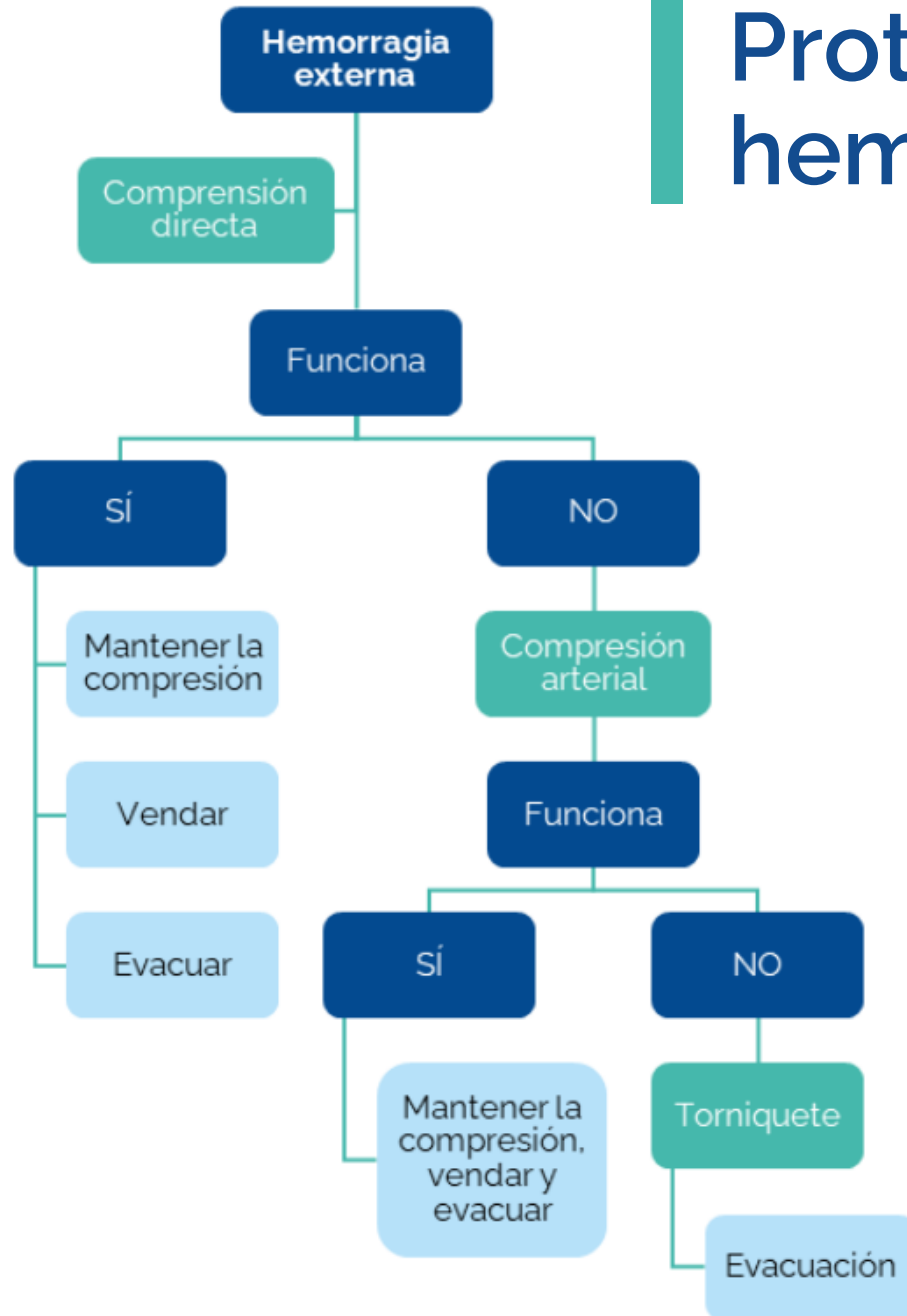
- Tranquilizar a la víctima.
- Llamar a los servicios de emergencia (112).
- Vigilar los signos de compromiso vital.
- Proteger a la persona del frío, el calor y retirar las prendas que puedan oprimir el cuerpo.
- Si la víctima está consciente la colocaremos en decúbito supino y si presenta vómito o esta inconsciente, pero respira en PLS.
- Si la víctima está inconsciente, abriremos la vía aérea y comprobaremos respiración. Y aplicaremos protocolo de SVB estudiado en unidades anteriores.



- Son difíciles de detectar
- Necesitan intervención médica urgente



Protocolo de actuación hemorragia externa





Hemorragia exteriorizada

Clasificación:

- **Epistaxis:** sangrado por la nariz.
- **Otorragia:** sangrado por el oído.
- **Rectorragia o melenas:** sangrado por el ano,
- **Hemoptesis:** sangrado por la boca de origen respiratoria.
- **Hematemesis:** sangrado por la boca de origen digestivo.
- **Metrorragia:** sangrado por la vagina procedente del útero y de origen distinto a la menstruación

EPISTAXIS	OTORRAGIA	HEMOPTISIS
Hemorragia exteriorizada por la nariz	Hemorragia exteriorizada por los oídos	Hemorragia exteriorizada por la boca
Cabeza recta o ligeramente inclinada hacia abajo	Puede ser debido a una fractura de cráneo	PLS
Presión directa con los dedos sobre la ventana nasal sangrante contra el tabique nasal	No taponar el oído sangrante	Vigilar los signos de compromiso vital
5-10 minutos	PLS con oído sangrante hacia el suelo	
Respirar por la boca	Control de los signos de compromiso vital	
Si la presión no hace que cese el sangrado, introducir una gasa con H ₂ O ₂	Asistencia sanitaria urgente	
Si no cesa, mantener la gasa y trasladar al centro sanitario		



Quemaduras

Lesión de la piel o de otros tejidos corporales causada por el calor, o debido a la radiación, radioactividad, electricidad, fricción o contacto con químico.

Los **agentes causantes** de las quemaduras son el calor, el frío, la electricidad, radiaciones o químicos.



Clasificación quemaduras



Primer grado

Son las más superficiales. solo afectan a las partes más externas de la piel. Causan enrojecimiento y leve inflamación y dolor.



Segundo grado

Alcanzan capas más profundas de la piel. Tienen aspecto rosado y producen dolor intenso y ampollas. Tardan más en curar. Pueden ser superficiales o profundas.



Tercer grado

Afectan a todas las capas de la piel, lesionando todas las terminaciones nerviosas. Estas quemaduras producen una gran afectación que debe ser atendida en el hospital.



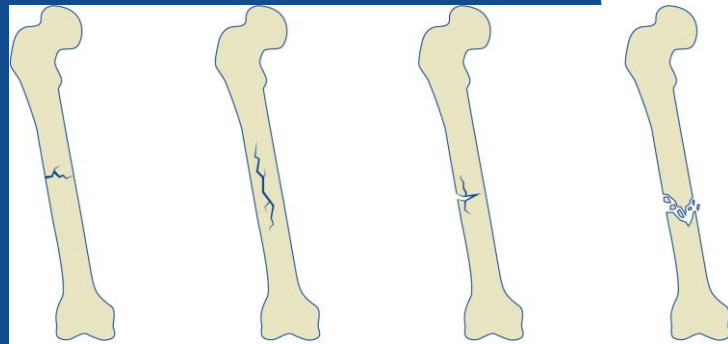
Protocolo de actuación ante quemaduras

- Pedir 112 y apartar el foco de calor.
- Si la víctima en llamas, hacerla rodar por el suelo o taparla con una manta.
- Retirar la ropa que no esté pegada a la piel.
- Retirar anillos, pulseras y relojes que conserven el calor del accidentado.
- No aplicaremos antisépticos, medicamentos, etc., sobre la víctima.
- En quemaduras químicas, aplicar abundante agua, sin salpicar otras partes del cuerpo.
- No tocar las ampollas en las quemaduras y tapar con apósitos estériles las zonas quemadas.
- Controlar los signos vitales. Si fuera necesario, comenzar maniobras RCP.
- Prevenir **shock**. Si es posible, decúbito supino y tapada.
- Trasladar a la víctima a un centro hospitalario.

Fracturas

Es un tejido duro que forma el esqueleto humano.

Fracturas: Roturas completas o incompletas de los huesos producidas, como norma general, por traumatismos directos o indirectos. Se pueden producir fracturas abiertas (rotura de la piel) o cerradas (no rotura de la piel).

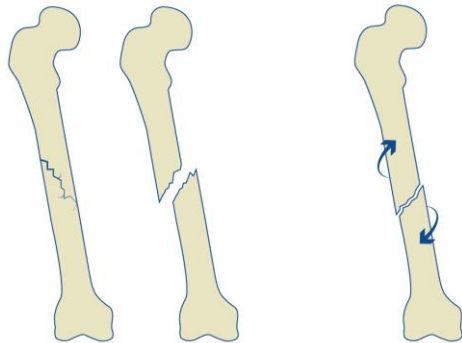


Transversa

Lineal

En tallo verde

Conminuta



Oblicua

Espiral

Se **clasifican** en:

- **Abierta:** presenta herida.
- **Cerrada:** no hay herida.

Protocolo de actuación en fractura cerrada:

1. Realizar una valoración primaria ABC.
2. Realizar una valoración neurológica (sensibilidad y movilidad).
3. Realizar una valoración vascular (color de la piel, temperatura, relleno capilar y pulsos distales).
4. Inmovilizar la zona afectada, por encima y por debajo de la zona afectada, evitando aplicar vendajes en la zona deformada.
5. Proteger térmicamente al accidentado.
6. Acudir a atención especializada.



Protocolo de actuación en fractura abierta

1. Aplicar el protocolo fracturas cerradas.
2. Detener la hemorragia aplicando presión ligera o por otros métodos alternativos.
3. Lavar la herida "a chorro" con agua, hacia fuera para arrastrar todo lo que pueda contaminar la herida, Si se dispone de suero fisiológico, será preferible utilizarlo en lugar de agua.
4. Cubrir la herida con material limpio, sin hacer presión.
5. Trasladar a un centro médico.
6. Nunca reducir la fractura y vigilar las constantes vitales y el acondicionamiento de la fractura mientras llegan los servicios de emergencia o se realiza el traslado.



Inmovilizaciones según zona de fractura

- **Fractura de mano:** hay que colocar la mano encima de una tablilla o similar que sobresalga de la muñeca y poniendo el brazo en cabestrillo.
- **Fractura de hombro:** es importante sujetar el brazo contra el tórax con el cabestrillo.
- **Fractura de brazo:** hay que inmovilizar el hombro y el codo con cabestrillo y en este caso la función de férula la realiza el tórax.
- **Fractura de codo:** Intentar mantener la misma posición de manera que en el caso en el que el codo esté flexionado, se debe utilizar un cabestrillo, y si está extendido una férula.
- **Fractura de vértebras:** en ese caso hay que mantener al accidentado a temperatura adecuada y tumbado sobre su espalda mientras se espera a los servicios especializados.
- **Fractura de cráneo:** Intentar una evacuación urgente a un centro hospitalario y mientras llega la ayuda especializada, poner al herido posición lateral de seguridad (PLS).
- **Fractura de pierna y rodilla:** hay que inmovilizar, bloqueando con férulas y ligaduras, tanto el tobillo como la rodilla.



Botiquines de primeros auxilios

Los botiquines son mochilas con el material imprescindible para atender rápidamente a un enfermo.

La elección del tipo de botiquín dependerá del lugar donde se ubique, del número de personas a las que hay que atender y de los conocimientos de quien lo utilice.

En un botiquín no tiene que faltar:

Material de autoprotección como mascarillas de protección. Guantes, etc.

Material para curas: suero fisiológico, gasas, esparadrapo, analgésicos y antitérmicos, antisépticos (clorhexidina), tijeras de punta redonda y pinzas.



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —